

## 2. Déroulement du séminaire

### Objectifs généraux

En prenant l'exemple d'un patient qui consulte son médecin traitant avec des symptômes d'un syndrome œdémateux survenant lors d'un syndrome néphrotique, on introduit l'étudiant à l'anamnèse, l'examen physique et l'examen des urines à connaître dans ce contexte.

Ce séminaire peut se dérouler en trois phases. La première phase est consacrée à l'anamnèse. Pour introduire cette phase, on peut pratiquer un jeu de rôle (exemple en annexe, à la fin de ce guide). On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse à connaître lors d'un syndrome néphrotique. Dans la deuxième phase, le formateur montre aux étudiants l'examen physique à pratiquer lors d'un syndrome œdémateux survenant dans le contexte d'un syndrome néphrotique. Il explique les renseignements que le médecin peut tirer de chaque partie de l'examen. L'accent doit être mis sur l'inspection et la palpation. Par la suite, les étudiants effectuent l'examen physique entre eux. Dans la dernière phase, on aborde l'examen des urines.

La mesure de la tension artérielle est enseignée dans les séminaires sur les signes vitaux et le système artériel.

### Objectifs spécifiques

#### 1. Prise de l'anamnèse

Reconnaître les symptômes principaux du syndrome œdémateux :

- Œdèmes: début, localisation, quantification, caractères "néphrotiques" des œdèmes (blancs, mous, symétriques, indolores, déclives).
- Prise pondérale: début et importance.
- Apparition d'urines "mousseuses".
- Rechercher d'autres événements importants synchrones à l'apparition des œdèmes.
- Connaître les antécédents personnels contributifs du patient, notamment les résultats d'éventuels examens d'urines ou de valeurs tensionnelles antérieurs.
- Rechercher la prise de médicament(s).

#### 2. Enseignement de l'examen physique

Il faut savoir :

- Inspecter les œdèmes.
- Palper les œdèmes (rechercher le signe du godet).
- Penser à peser le patient.
- Rechercher les épanchements séreux :
  - l'ascite : inspection, palpation, percussion avec les changements de position. La sémiologie de l'ascite a déjà été abordée au sujet de la cirrhose hépatique (Unité 5, CCDC " Sémiologie digestive 3 "). Le formateur encouragera les étudiants à se souvenir eux-mêmes de ces notions.
  - les épanchements pleuraux: auscultation (absence du murmure vésiculaire), palpation (absence de transmission des vibrations vocales), percussion (matité). La sémiologie du système respiratoire n'a pas encore été vue à ce stade. En fonction du temps disponible, le formateur choisira ou non d'introduire les signes de l'épanchement pleural.
  - En revanche, la nécessité de rechercher systématiquement un épanchement pleural cas de syndrome œdémateux doit être connue des étudiants.
- Rechercher les signes accessoires au niveau des phanères :
  - ongles (double bandes transversales blanches);
  - peau (couleur jaune pâle, due à l'urochrome et au carotène. L'hypoalbuminémie du syndrome néphrotique s'accompagne d'une hypergammaglobulinémie compensatrice, avec notamment augmentation des

- globulines liant le carotène);
- cheveux (cassants, perte de cheveux).
- Palper et percuter les loges rénales.
  - rein droit : la palpation se fait avec la main droite (bout des doigts) de l'examineur en dessous du rebord costal droit et la main gauche en arrière du flanc droit, entre le rebord costal et la crête iliaque. Une palpation profonde peut permettre d'atteindre le pôle inférieur du rein droit (descend lors de l'inspiration).
  - rein gauche : la même technique est utilisée, mais l'examineur se met du côté gauche du patient. Comme le rein gauche est plus haut situé que le droit, son pôle inférieur est rarement palpable;
  - pour percuter les loges rénales, il faut asseoir le patient. L'examineur se place derrière le patient et percute la région costovertébrale des deux côtés.

### **3. Enseignement de l'examen des urines**

Il faut savoir:

- Regarder l'aspect des urines (couleur, transparence, brillance).
- Connaître l'examen de la bandelette réactive en cas de syndrome néphrotique (albumine +++, hématies négatives, leucocytes négatifs, nitrites négatifs).